

Guide d'administration

Protocole *Topotecan*

Rédaction : 23 octobre 2015

Révision : 23 octobre 2015

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Cancer du poumon à petites cellules qui récidive après une chimiothérapie de 1^{ère} ligne¹⁻³.

Visée palliative.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻³

Le topotécan est administré une fois par jour pendant cinq jours consécutifs aux 3 semaines (cycle de 21 jours) jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻³

Médicament	Dose	Description
Topotécan	1,5 mg/m ² /jour DIE x 5 jours	IV soluté ; dans 50 à 100 ml de NaCl 0,9% ou Dextrose 5% en 30 minutes

Cycle répété aux 21 jours

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

- › Aucune

Considérations spéciales :

- › Aucune
-

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable
- › **Antéémétiques** : potentiel émétique faible (10-30%)⁴
 - Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV DIE pour 5 jours pré-chimiothérapie. Alternatives : métoclopramide 10 mg PO ou IV ou prochlorperazine 10 mg PO.
 - Post-chimiothérapie : prochlorperazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Topotécan	Clcr 20 - 39 mL/min	0,75 mg/m ² /jour
	Clcr < 20 mL/min	Non recommandé

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique¹

Médicament	Bilirubine totale (μmol/L)	Ajustement posologique recommandé
Topotécan	< 171	Aucun ajustement requis
	≥ 171	Aucune donnée

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,3}

3.3.1 Niveaux de doses

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Topotecan	1,5 mg/m ² /jour	1,25 mg/m ² /jour	1 mg/m ² /jour

3.3.2 Tableau d'ajustement*

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,0	et	≥ 100	100 % de la dose
≥ 1,0	et	50-99	Retarder le traitement, puis reprendre à la même dose lorsque plaquettes ≥ 100.
< 1,0 neutropénie fébrile	ou et/ou	< 50	Retarder le traitement, puis réduire d'un niveau de dose une fois toxicité hématologique résolue. L'utilisation du filgrastim pourrait être envisagée en cas de neutropénie selon le jugement clinique.

* Ces recommandations sont basées en partie sur un consensus d'expert.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4³

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Grade 3 ou 4**	Retarder le traitement.
	Reprendre lorsque toxicité ≤ grade 1 et réduire d'un niveau de dose.

* Ces recommandations sont basées en partie sur un consensus d'expert.

** Version du CTCAE non spécifiée.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est la toxicité la plus fréquente du topotécan et peut être sévère. Des neutropénies de grade 4 ont été rapportées chez 70 % des patients². En cas de neutropénie, il est recommandé de retarder le traitement, puis de réduire la dose selon la sévérité de la neutropénie (Voir [section 3.3. - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). L'utilisation du filgrastim peut être envisagée dans certains cas.

La **thrombocytopénie** peut aussi survenir et nécessiter des réductions des doses (Voir [section 3.3. - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). L'**anémie** est également possible².

L'**alopécie** partielle est fréquente et peut être totale chez environ un tiers des cas¹.

Les **nausées et vomissements** sont fréquents, mais généralement de faible intensité et bien contrôlés avec la médication antiémétique (Voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹. Les autres effets secondaires gastro-intestinaux possible sont les stomatites et la diarrhée, mais sont généralement de faible intensité².

La **fatigue** est un effet secondaire assez fréquent mais n'est généralement pas sévère².

La **fièvre** durant les jours de traitements (non reliée à une infection) a été rapportée^{1,3}.

Le topotécan peut être **irritant** pour les veines⁵.

Des cas de **pneumopathie interstitielle** ont été rapportés suite à l'utilisation du topotécan, dont certains ont été fatals. Le traitement doit être interrompu en cas de toux, dyspnée, fièvre et hypoxie. Il n'est pas recommandé de reprendre le traitement si un diagnostic de maladie pulmonaire interstitielle est posé¹.

Des cas de **colite neutropénique** ont également été rapportés dont certains ont été fatals¹.

Tableau des effets indésirables²

Effets secondaires (n=104)	Grade* 1/2 (%)	Grade* 3/4 (%)
Neutropénie	n/d	88,5
Leucopénie	n/d	86,5
Thrombocytopénie	n/d	57,6
Anémie	n/d	42,3
Nausées	35,5	3,7
Alopécie	35,5	n/d
Vomissements	22,4	1,9
Fatigue	21,5	4,7
Stomatite	12,2	1,8
Diarrhée	11,2	0,9
Fièvre reliée au traitement	10,3	1,9

n/d : information non disponible

*Version du CTCAE non spécifiée

4.2. Interactions cliniques significatives⁶

Le topotécan est un substrat du BCRP (*breast cancer resistance protein*) et du PGP. Des interactions théoriques sont décrites en relation avec ce métabolisme, par contre la portée clinique de ces interactions n'est pas bien documentée.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Phénytoïne	↓ des concentrations plasmatiques de topotécan par augmentation de sa clairance. <i>Sévérité : majeure</i>	Si possible, éviter la co-administration.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, bilirubine totale, créatinine sérique
Avant chaque traitement	FSC, bilirubine totale, créatinine sérique

5. Références

1. GlaxoSmithKline Inc. Monographie de Topotecan (Hycamtin). Mississauga, Ontario. Juillet 2015.
2. Ardizzoni A, Hansen H, Dombernowsky P, Gamucci T, Kaplan S, Postmus P et coll. Topotecan, a new active drug in the second-line treatment of small-cell lung cancer: A phase II study in patients with refractory and sensitive disease. *J Clin Oncol* 1997;15:2090-6.
3. Von Pawel J, Schiller JH, Shepherd FA, Fields SZ, Kleisbauer JP, Chrysos NG et coll. Topotecan versus cyclophosphamide, doxorubicin and vincristine for the treatment of recurrent small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 1999;17:658-67.
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
6. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 8 septembre 2015.